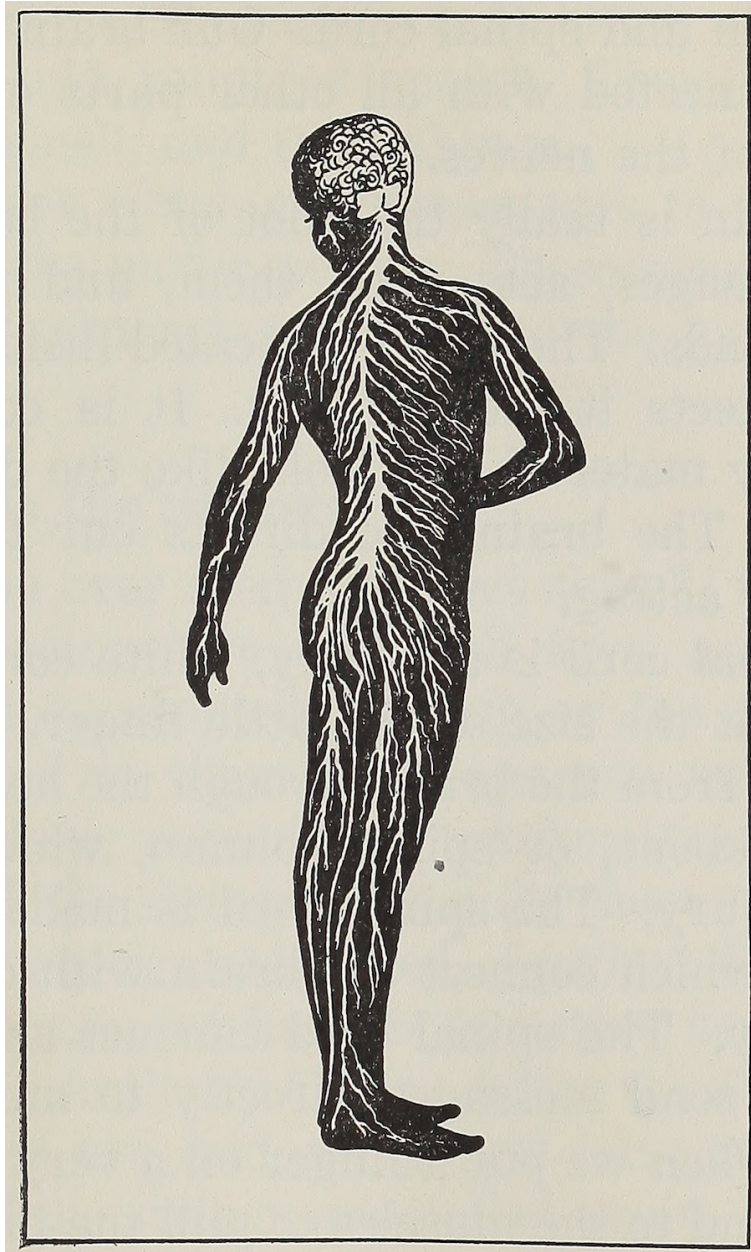
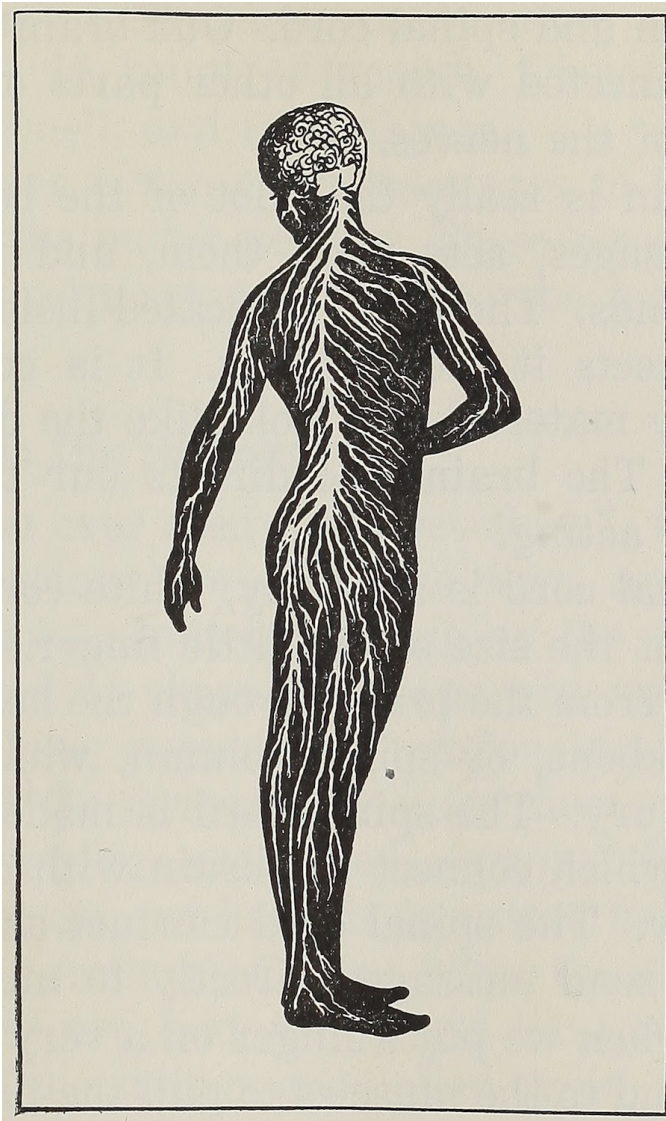


Neurologie : Pathologies fréquentes



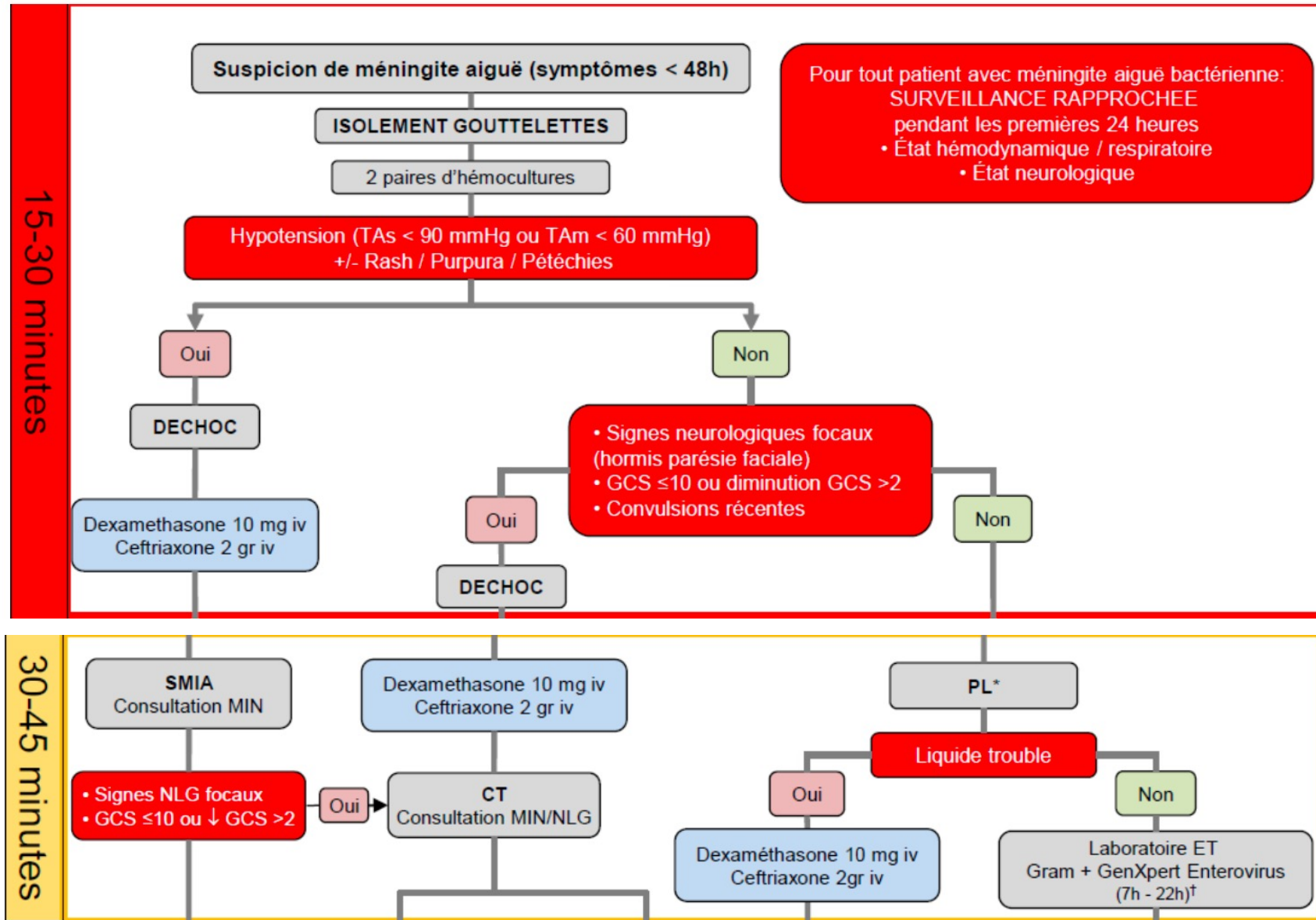


Méningite

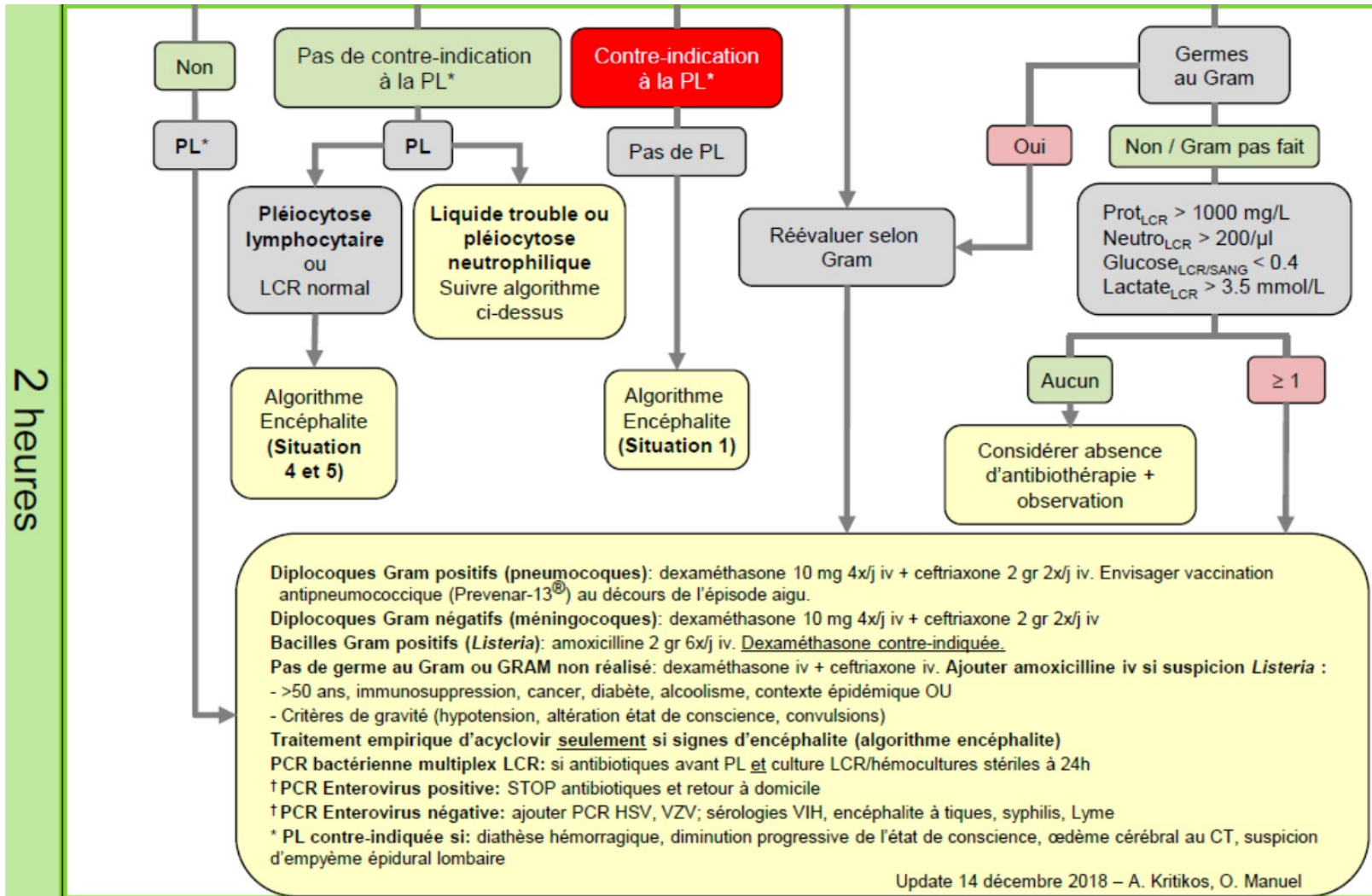
- **Red flag:** **État fébrile**, **céphalées**, raideur de nuque (**méningisme**), **pétéchies**, **HTIC** (céphalées horizontale, vomissement en jet), **photo-** et **phonophobie**
- **Status:** Chercher des signes neurologiques focaux (méningo-encéphalite ?), au lit du malade
 - Nerfs crâniens
 - Examen NLG rapide : Force et sensibilité, test cérébelleux, dérive en pronation, méningisme, ROT
 - Dermatologique : Chercher des pétéchies sur tout le corps
 - Chercher un foyer infectieux : immunosuppression, angine, otite, pneumonie, herpes, tiques ...
 - Chercher un choc septique : Mesure de la T° artérielle, FC, FR, GCS
- **Prise en charge :**
 - **Choc** (TAS < 90 mmHg ou/et TAM < 60 mmHg) → Immédiatement **hémoculture** + **Ceftriaxone IV** + **DMX IV**, puis **PL***
 - **Absence de choc et de CI à la PL*** → Immédiatement **PL** + **hémoculture**, puis si liquide trouble **Ceftriaxone IV** + **DMX IV**
 - Absence de choc mais **CI à la PL*** → Immédiatement Immédiatement **hémoculture** + **Ceftriaxone IV** + **DMX IV**, puis **CT**

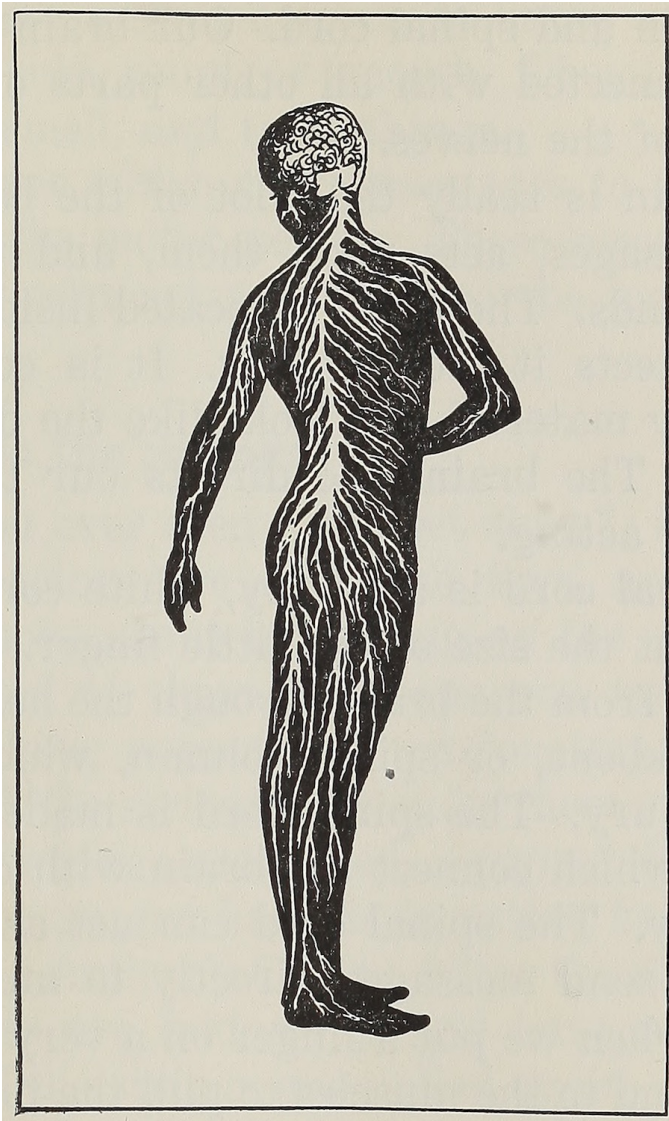
*CT avant PL si : Crises épileptiques récente, CGS ≤ 10, déficit NLG focal

Algorithme méningite



Algorithme méningite



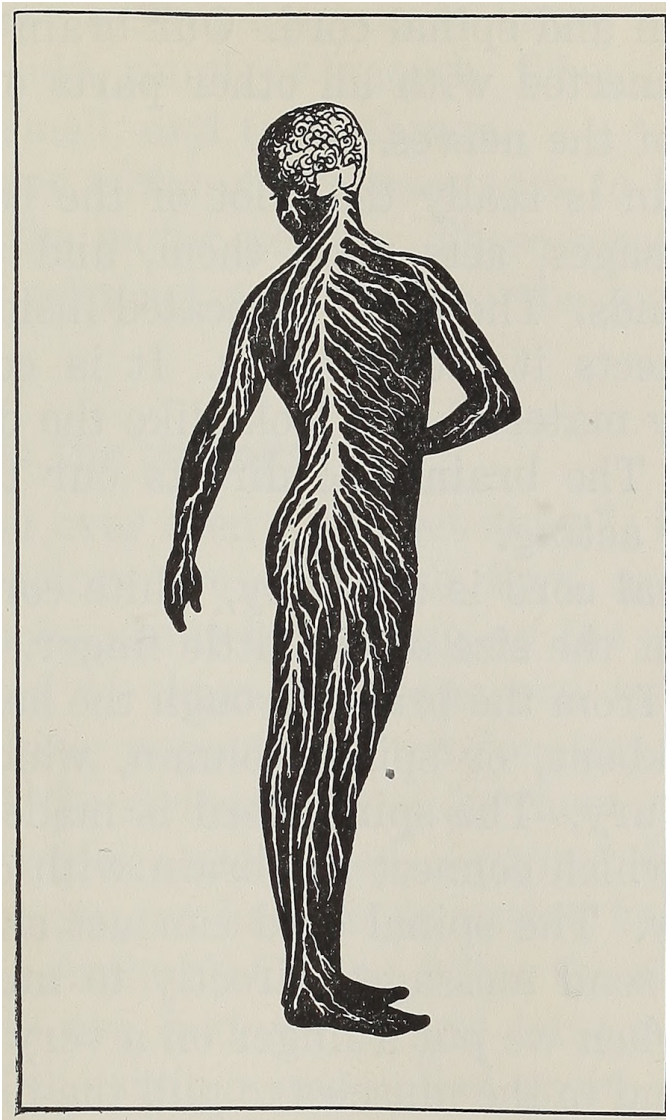


AVC

- **Red flag: N'importe quel déficit neurologique d'apparition subite**
Typiquement: Hémiplégie, dysarthrie, aphasie, céphalées, vertige, ataxie, troubles oculomoteurs
- **Status:** Chercher des signes neurologiques focaux (identification du niveau de la lésion)
 - Nerfs crâniens
 - Examen NLG rapide: Force et sensibilité, test cérébelleux, mouvement alternant précis et rapide, ménigisme*, ROT, test de Barrés et Mingazzini, Romberg, dérive en pronation, marche
**Présence d'un ménigisme en cas d'AVC avec HSA*
- **Prise en charge**: Déclenchement filière AVC (imagerie: CT-scan d'urgence)

Céphalées (migraine ± aura, céphalées de tension, Horton, thrombose sinus-veineux, en grappe, trigéminales)

- **Red flag:**
 - **Type**: la plus forte jamais arrivé, en coup de tonnerre, différentes des céphalées habituelles
 - **Contexte**: femme enceinte/post-partum (**PRES, thrombose**), >50 ans (**Horton**),
 - **Syndrome**: HTIC (vomissement en jet et céphalés au réveil, flou visuel),
Hypotension intra-crânienne (Céphalées orthostatique, ANTCD de PL/épidural, fuite LCR nez/oreil),
Ménigisme (Raideur nuque, nausées et vomissements)
- **Status:** Chercher des signes neurologiques focaux (oriente vers un autre diagnostic ou la présence d'aura)
 - Nerfs crâniens
 - Examen NLG rapide: Force et sensibilité, test cérébelleux, mouvement alternant précis et rapide, ménigisme*, ROT, test de Barrés et Mingazzini, Romberg, dérive en pronation, marche
**Présence d'un ménigisme en cas d'AVC avec HSA*
 - **Migraine**: 4-72h, pulsatile, unilatérale, renforcée par l'activité physique, photophobie et phonophobie
 - **Céphalées de tensions**: 30 minutes à 7 jours, bilatérale, étau, non pulsatile, soulagé par l'activité
 - **Hémicrânie trigémino-dysautonomique**: très sévère, orbitaire, avec myosis/sudation/ptose/congestion nasale/rhinorrhée et agitation importante → donner O2 haut-débit + triptan intra-nasal/injectable, toujours effectuer une IRM au moment du diagnostic
 - **Néuralgie du trijumeau**: douleurs neuropathique paroxystique, épargne l'encoche massétérine, la présence d'une hypo-esthésie (face, cornée) oriente vers une cause secondaire (SEP, Zona, neurinome...) → Toujours effectuer une IRM au moment du diagnostic

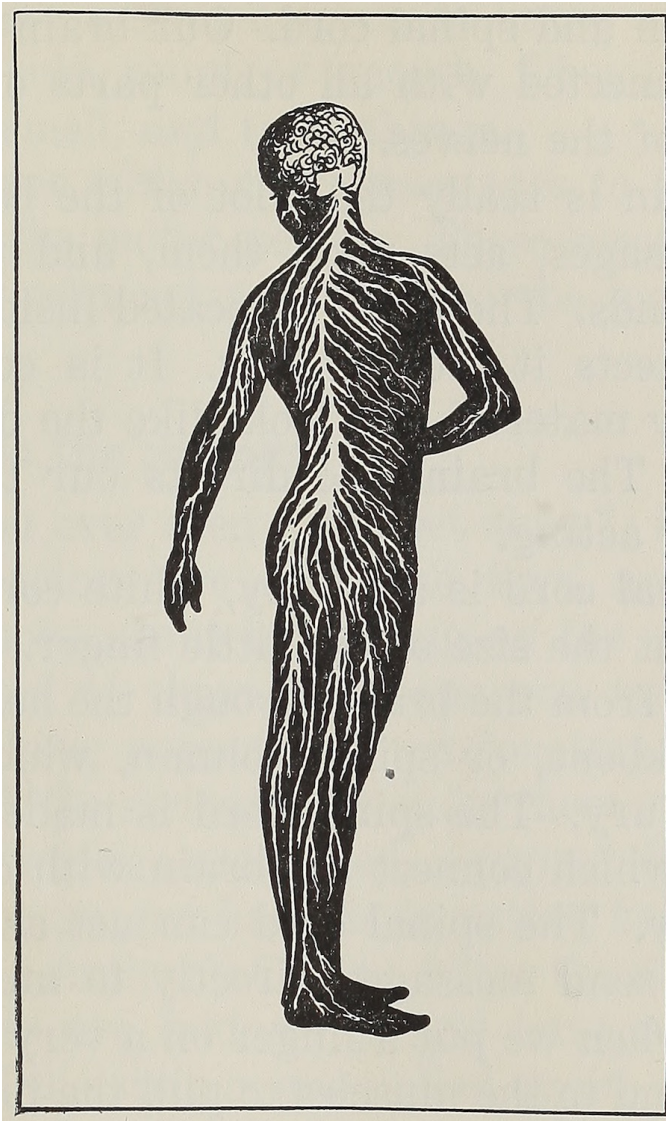


Encéphalopathie de Wernicke :

- **Définition** : Encéphalopathie aiguë et atteinte cérébelleuse dans le cadre d'une carence en vitamine B1. Particulièrement fréquent dans la population âgée et alcoolique
- **Cliniquement** : Triade composée d'une **confusion**, **trouble de l'oculomotricité** et d'une **ataxie**
- **Diagnostic** : Le diagnostic est généralement clinique, avec une atteinte compatible et une réponse au traitement
- **Status**: Mise en évidence d'une atteinte cérébelleuse
 - Nerfs crâniens
 - Examen NLG rapide : Force et sensibilité, test cérébelleux, mouvement alternant précis et rapide, ménigisme*, ROT, test de Barrés et Mingazzini, Romberg, dérive en pronation, Unterberger, marche
- **Prise en charge** : Hospitalisation, administration de **thiamine IV** sur 3 jours puis **PO** au long court

Épilepsie et crise épileptique :

- **Définition** : La crise épileptique est la survenue transitoire de signes ou symptômes dus à une activité neuronale excessive ou synchrone. On distingue la « crise épileptique » de la « épilepsie-maladie ».
- **Prise en charge** :
 - Distinguer la crise épileptique de ces DD, en premier lieu la **syncope convulsivante** et la **PNES**
 - Repérer une crise d'épilepsie provoquée (n'entre pas dans le cadre de l'épilepsie-maladie) : Post-**AVC** ou **TCC**, au décours d'une **méningite** ou d'une encéphalite, troubles **électrolytiques** et **IRA**, lors d'un **sevrage** à l'alcool ou aux BZD, lors de la prise de cocaïne ou de MDMA (ecstasy)
 - S'il s'agit d'une crise épileptique non provoquée, estimer s'il s'agit de la première ou d'une récurrence
 - S'il s'agit d'une crise épileptique non provoquée sans facteur de gravité: faire au minimum un **laboratoire** avec électrolytes, fonction rénale et glycémie. On organisera en ambulatoire un **EEG** et un **CT-injecté**. En présence de facteur de gravité (ECA, état de mal, déficit neurologique focal au status, TCC, immunosuppression, traitement anticoagulant, céphalées, fièvre...) : PL, CT et EEG aux urgences.



Myélopathie : Section complète

- **Description** : Atteinte bilatérale de tous les tracts (**sensitifs moteurs, végétatifs**) avec niveau supérieur conservé et une **paralysie flasque** et des **fasciculation** au niveau de la lésion. En dessous, **paralysie spastiques**.
- **Status** : Chercher le niveau de l'atteinte et le type de modalités touchées
 - Nerfs crâniens
 - Examen NLG rapide : Force et sensibilité, test cérébelleux, mouvement alternant précis et rapide, ménigisme*, ROT, test de Barrés et Mingazzini, Romberg, dérive en pronation, marche
- **Prise en charge** : Imagerie (**IRM**), test fonctionnel (**ENMG**)

Myélopathie : Syndrome de Brown-Séquart

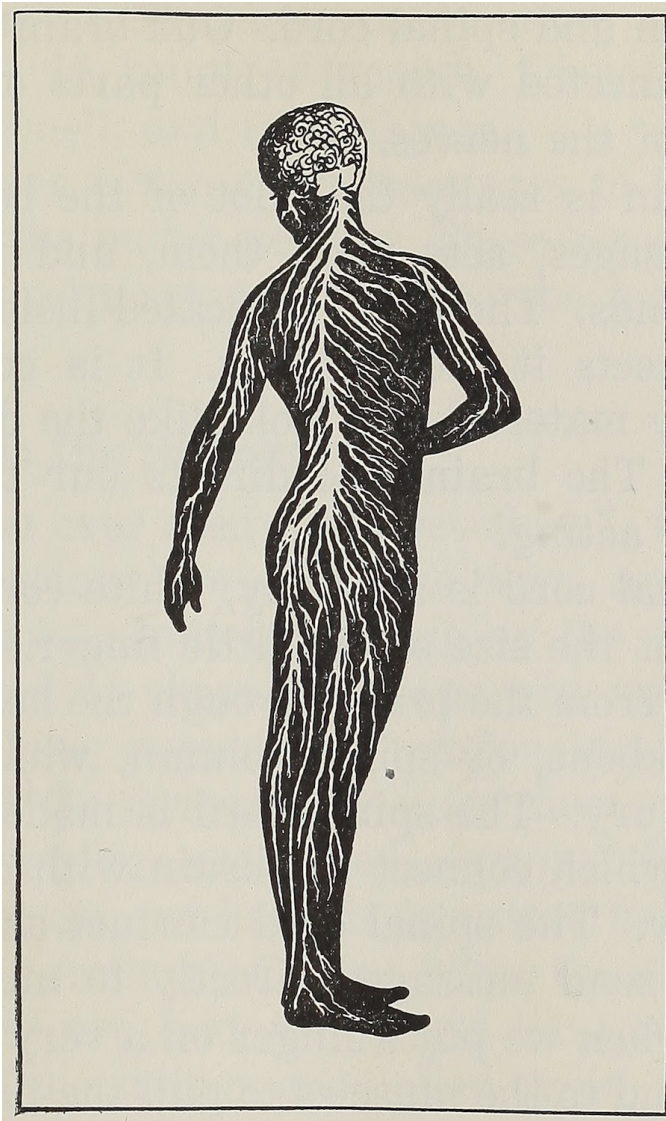
- **Description** : Atteinte unilatérale d'une moitié de la moelle.
 - **Ipsilatéralement** : Atteinte de la voie pyramidale (motrice) et de la voie lemniscale (cordon postérieur)
 - **Controlatéralement** : Atteinte de la **voie spino-thalamique** mais conservation des voies pyramidale/lemniscal
 - **Au niveau de la lésion** : Paralysie flasque et spasticité, en dessous paralysie spastique.
- **Status** : Chercher le niveau de l'atteinte et le type de modalités touchées
 - Nerfs crâniens
 - Examen NLG rapide : Force et sensibilité, test cérébelleux, mouvement alternant précis et rapide, ménigisme*, ROT, test de Barrés et Mingazzini, Romberg, dérive en pronation, marche
- **Prise en charge** : Imagerie (**IRM**), test fonctionnel (**ENMG**)

Myélopathie : Syndrome spinale antérieur

- **Description**: Destruction du cordon antérieur (voie pyramidale)(uni- ou bilatérale)
- **Au niveau de la lésion** : Paralysie flasque et spasticité
- **En dessous du niveau** : Parésie, spasticité

Myélopathie : Syndrome spinale postérieur

- **Description**: Destruction du cordon postérieur (voie lemniscale)(uni- ou bilatérale)
- **En dessous du niveau** : Perte sensibilité fine, de la proprioception, de la vibration ipsilatérale
Conservation T° et douleurs ipsilatérale (voie spino-thalamique)

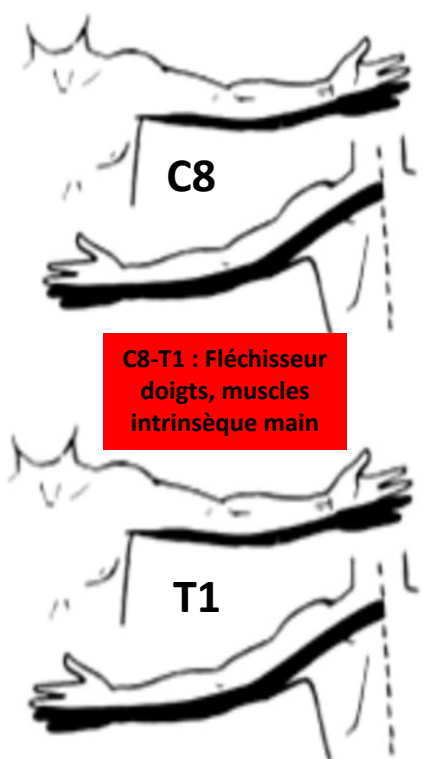
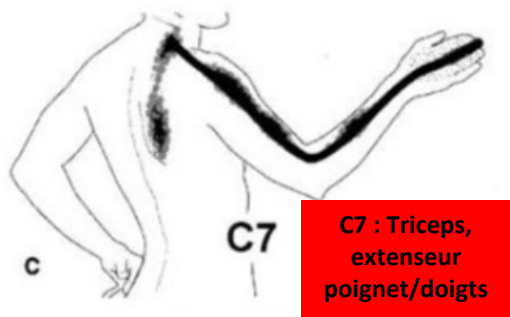
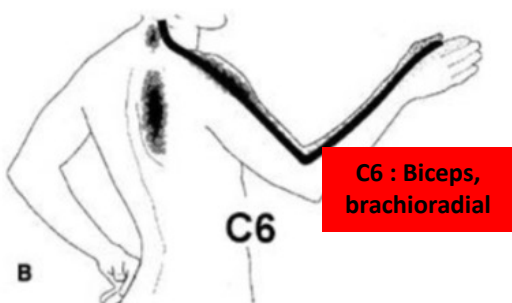
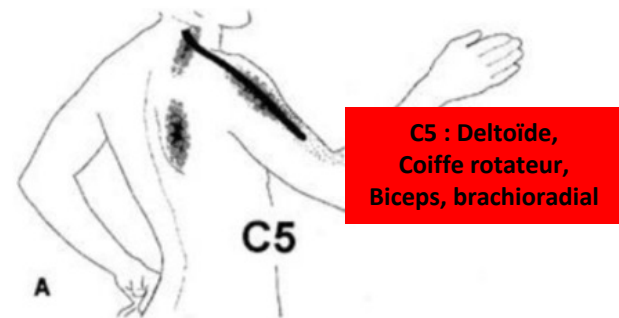


Guillain-Barré : Polyradiculonévrite aiguë

- **Description** : Déficit **se** **ivo-moteur non longueur dépendant** (proximo-distal),
 - Relativement symétrique, **début aigu** et à environ 3 semaines d'un épisode viral/vaccination
 - Avec une atteinte marquée des grosses fibres proprioceptives (**aréflexie généralisée**).
 - Conservation de la sensibilité thermo-algique
- **Status** :
 - Nerfs crâniens
 - Examen NLG rapide : Force et sensibilité, test cérébelleux, mouvement alternant précis et rapide, méningisme*, ROT, test de Barrés et Mingazzini, Romberg, dérive en pronation, marche
 - Chercher des signes de gravité: Dyphagie, dyspnée, arythmie
- **Prise en charge** : **Hospitaliser** si signes de gravités, faire une **sérologie** pour *C. jejuni*, traiter avec immunomodulateur (**IgIV 0.4g/kg**)

Polyneuropathie (Diabétique)

- **Description**: Déficit sensitif principalement dépendant et symétrique (en chaussettes puis en gant),
 - Souvent accompagné de dysesthésie douloureuse (atteinte des fibres thermo-algique)
 - Peut s'accompagner d'une légère parésie (4/5)
- **Status** :
 - Examen NLG rapide : Force et sensibilité, test cérébelleux, mouvement alternant précis et rapide, méningisme*, ROT, test de Barrés et Mingazzini, Romberg, dérive en pronation, marche

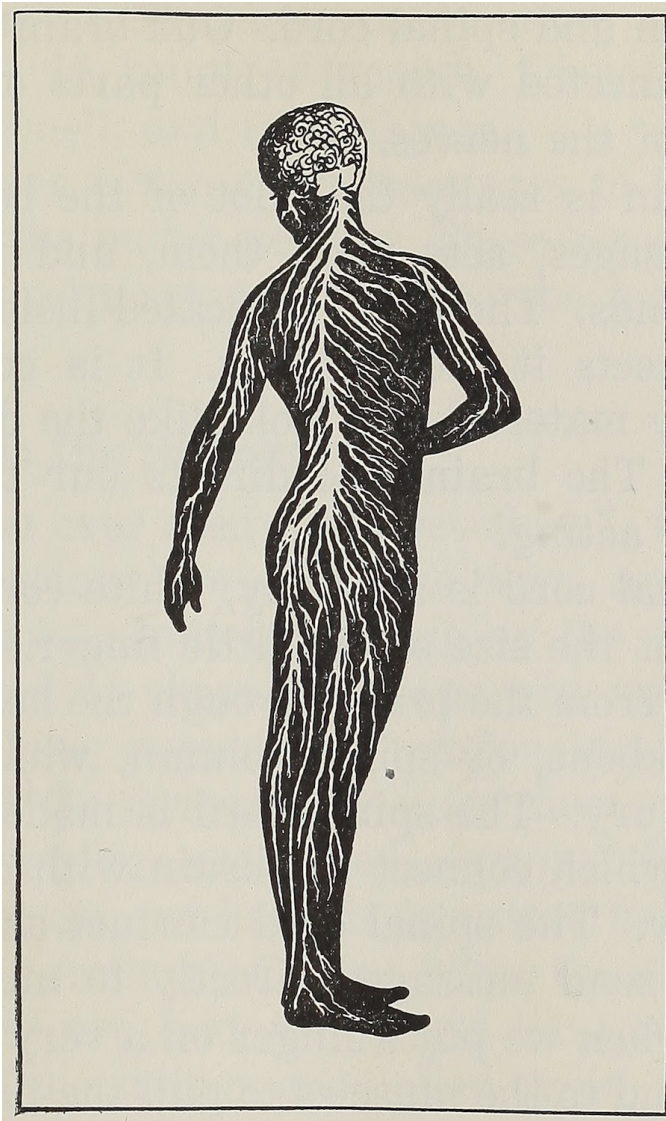


Radiculopathie :

- **Description** : Association d'un **syndrome rachidien** (mal de dos, torticolis) et d'un **syndrome radiculaire** (atteinte d'une racine nerveuse). On distingue l'atteinte radiculaire irritative et déficitaire
 - **Radiculopathie irritative** : Douleurs neuropathique [**Dermatomes**]
cave : Symptôme d'abord en périphérie du dermatome
 - **Radiculopathie déficitaire** : Déficit moteur, amyotrophie [**Myotomes**] et hypoesthésie, anesthésie [**Dermatomes**]
cave : Atteinte déficitaire uniquement en cas de compression avancée
- **Status** : Rechercher des signes de souffrances médullaires (niveau sensitif, hémis syndrome, troubles sphinctériens...)
 - Examen NLG rapide : Force et sensibilité, test cérébelleux, mouvement alternant précis et rapide, ménigisme*, ROT, test de Barrés et Mingazzini, Romberg, dérive en pronation, marche
 - Test spécifique: Déclenchement symptôme nerveux par compression/étirement.
Test de Spurling (racines cervicales), ou Lasèque/Lasèque inversé (racines lombo-sacrées)
- **Prise en charge** : Si syndrome irritatif sans syndrome de la queue de cheval et sans douleurs incontrôlable
1 mois de traitement 1^{ère} ligne : Antalgie (OMS), Médecine manuelle, courte corticothérapie (**pas imagerie**)
2 semaines traitement 2^{ème} ligne : Médicament anti-douleurs neuropathique, infiltration épidurale
Si >6 semaines de traitement bien conduits : avis chirurgical, imagerie

Syndrome de la queue de cheval

- **Description**: Compression brutal plusieurs nerfs rachidiens (queue de cheval)
Anesthésie en selle, troubles sphinctériens, diminution du tonus anal pouvant être accompagné de déficit sur les racines sensitivo-motrices des membres inférieur
- **Status** :
 - Examen NLG rapide : Force et sensibilité, test cérébelleux, mouvement alternant précis et rapide, ménigisme*, ROT, test de Barrés et Mingazzini, Romberg, dérive en pronation, marche
 - Test spécifique: Tonus anal
 - **Prise en charge** : Urgence absolue, **IRM** ou **CT** et **avis chirurgical**

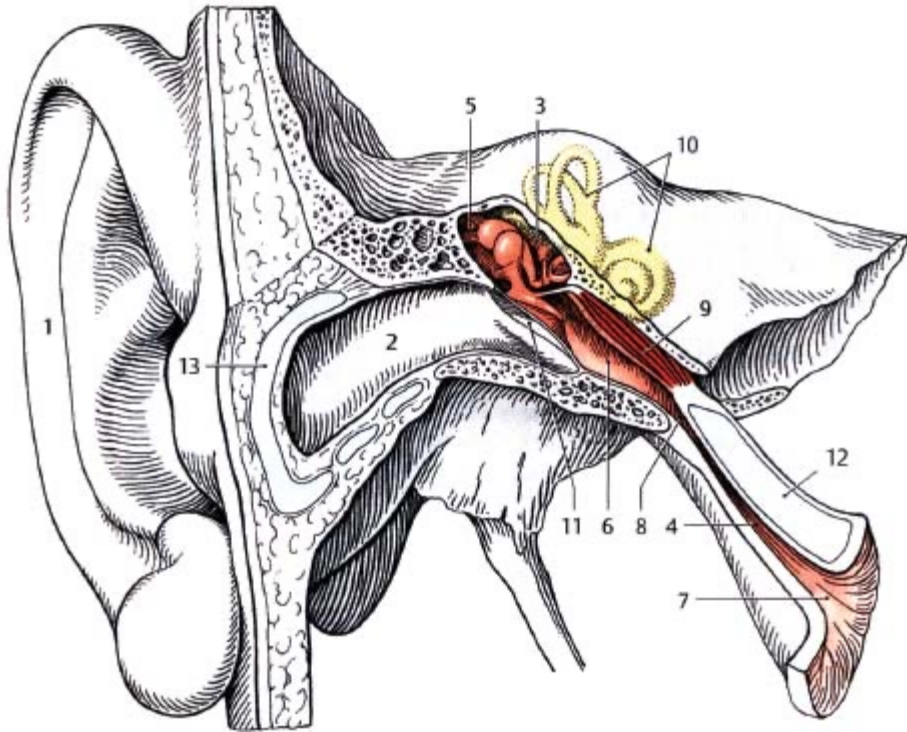


Mononeuropathie : syndrome canalaire

- **Description:** Compression d'un nerf périphérique avec altération des modalités sensitivo-motrices. Typiquement : nerfs **médian, ulnaire, radial, fibulaire**
- N. median : abduction pouce, innervation sensitive doigts 1-3
- N. ulnaire : abduction des doigts et Froment, innervation sensitive doigt 5
- N. radial : extension avant-bras et doigts, innervation sensitive dorsale doigts 1-3
- N. fibulaire : dorsi-flexion du pieds, éversion, innervation orteil 1-4
- **Status** : Caractériser l'atteinte nerveuse. Toujours bilatérale !
- Sensibilité et force selon le nerf touché
- Déclenchement de l'atteinte avec test de Phanel et de Tinel

Mononeuropathie multiple

- **Description:** Atteintes rapide de plusieurs nerfs périphériques.
- **Status** : Caractériser l'atteinte nerveuse. Toujours bilatérale !
- Examen NLG rapide : Force et sensibilité, test cérébelleux, mouvement alternant précis et rapide, ROT, test de Barrés et Mingazzini, Romberg, dérive en pronation, marche
- **Prise en charge** : Possiblement une urgence (vasculite). **ENMG, biopsie** et avis **neurologique+**



Vertige : Maladie de Menière

- **Surdité fluctuante** (en particulier sons graves), **accouphènes**, **vertiges** (minutes à heures)
- **Status** : Chercher des déficits neurologiques (DD: AVC)
- Nerfs crâniens
- Examen NLG rapide : Force et sensibilité, test cérébelleux, mouvement alternant précis et rapide, ménigisme, ROT, test de Barrés et Mingazzini, Romberg, dérive en pronation, marche
- Test spécifique : Surdit  de neuro-sensorielle au **Weber + Rinne**

Vertige : BPLS

- **Vertiges** intense durant quelques minutes lors de **mouvement rotatoire de la t te**
- **Pas de perte auditive**
- **Status** : Chercher des d ficits neurologiques (DD: AVC)
- Nerfs cr niens
- Examen NLG rapide : Force et sensibilit , test c r belleux, mouvement alternant pr cis et rapide, m ningisme, ROT, test de Barr s et Mingazzini, Romberg, d rive en pronation, marche
- Test sp cifique : **Dix-Hallpike**

Vertige : Neuronite du NC.VIII

- **Vertiges** de longue dur e avec **chute et nystagmus** ipsilat rale. **Pas de perte auditive**
- **Status** : Chercher des d ficits neurologiques (DD: AVC)
- Nerfs cr niens
- Examen NLG rapide : Force et sensibilit , test c r belleux, mouvement alternant pr cis et rapide, m ningisme, ROT, test de Barr s et Mingazzini, Romberg, d rive en pronation, marche
- Test sp cifique : **Halmagyi**

Vertige : Labyrinthite

- Infection/inflammation de l'oreille interne avec acouph ne, vertige, nystagmus, fi vre, surdit  de perception, naus e et vomissement. Foyer infectieux: M ningite, **otite moyenne**, **masto dite**
- **Status** : Chercher des d ficits neurologiques (DD: AVC), un m ningisme (m ningite surajout e)
- Nerfs cr niens
- Examen NLG rapide : Force et sensibilit , test c r belleux, mouvement alternant pr cis et rapide, m ningisme, ROT, test de Barr s et Mingazzini, Romberg, d rive en pronation, marche
- Test sp cifique : Surdit  de neuro-sensorielle au **Weber + Rinne**, **Otoscopie** (OMA)
- **Prise en charge** : **IRM** ou **CT** de la base du cr ne + **Ceftriaxone IV**